PENGEMBANGAN APLIKASI DIGITAL PELAPORAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) BERBASIS MOBILE DAN WEB

KUESIONER PENELITIAN

A. Kebijakan, Organisasi, dan SDM K3

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Puskesmas memiliki kebijakan/program K3 tertulis.					
2	Kebijakan K3 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Puskesmas.					
3	Komitmen/kebijakan K3 tertulis disosialisasikan kepada seluruh SDM dan diletakkan di tempat strategis yang dapat dibaca pengunjung.					
4	Puskesmas memiliki Tim/Petugas K3 yang ditunjuk secara resmi (Surat Keputusan).					
5	Tersedia sumber daya untuk pelaksanaan program K3 Puskesmas.					
6	SDM Puskesmas (khususnya Tim/Penanggung Jawab K3) pernah mengikuti pelatihan/peningkatan kompetensi K3 yang sesuai standar kurikulum dan sertifikasi Kementerian Kesehatan.					
7	Puskesmas pernah memberikan pelatihan/sosialisasi K3 kepada pegawai dalam 1 tahun terakhir.					
8.	Puskesmas memiliki rencana kerja/program K3 (tahunan) dengan sasaran yang jelas dan terukur.					
9	Perencanaan K3 Puskesmas melibatkan unit terkait.					
10	Program K3 Puskesmas dilaksanakan sesuai rencana kerja.					
11	Puskesmas memiliki SOP pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja (PAK).					
9	Puskesmas melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala bagi SDM minimal 1 (satu) tahun sekali.					
10	Puskesmas membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tempat kerja, termasuk larangan merokok.					

B. Pencatatan dan Pelaporan Insiden K3

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Pelaporan K3 di Puskesmas masih dilakukan secara manual (kertas) atau spreadsheet terpisah.					
2	Data pelaporan K3 antar unit/poli di Puskesmas belum terintegrasi dalam satu sistem.					
3	Puskesmas belum memiliki dashboard/monitoring insiden K3 secara real-time.					
4	Puskesmas pernah mengalami keterlambatan, kehilangan, atau duplikasi data laporan K3.					
5	Analisis tren kecelakaan kerja dan PAK sulit dilakukan dengan sistem pelaporan yang berjalan saat ini.					
6	Puskesmas melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3 secara tahunan (seluruh pelaksanaan kegiatan K3 selama 1 tahun).					
7	Laporan semester mencakup jumlah SDM, SDM sakit, kasus penyakit umum, dugaan PAK, PAK, kecelakaan akibat kerja, kejadian hampir celaka (near miss), dan hari absen karena sakit.					
8	Laporan K3 diketahui/ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Ketua Tim/Penanggung Jawab K3.					
9	Puskesmas melakukan investigasi pada setiap kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja.					
10	Puskesmas mencatat kejadian hampir celaka (near miss) pada SDM.					
11	Insiden dan kecelakaan kerja dicatat dan dilaporkan.					

C. Identifikasi dan Pengendalian Risiko Kerja

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Puskesmas melakukan identifikasi bahaya biologis (agen infeksius) secara berkala.					
2	Puskesmas melakukan identifikasi bahaya kimia (disinfektan/obat) secara berkala.					
3	Puskesmas melakukan identifikasi bahaya fisik dan ergonomi (postur kerja) secara berkala.					
4	Puskesmas menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi tenaga kesehatan.					
5	Puskesmas memiliki mekanisme pemantauan risiko psikososial (stres/beban kerja) pegawai.					
6	Puskesmas melakukan penilaian risiko (analisis dan evaluasi tingkat risiko tinggi, sedang, rendah) terhadap bahaya yang telah diidentifikasi.					

7	Puskesmas memiliki peta/daftar risiko K3 untuk setiap ruangan/unit pelayanan.					
8	Puskesmas menerapkan prinsip ergonomi (penanganan beban manual, postur kerja, gerakan berulang, pengaturan shift dan durasi kerja, tata letak ruang kerja).					
9	Puskesmas melakukan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung, listrik, pencahayaan, grounding, ventilasi, sanitasi) dari aspek K3.					
10	Puskesmas mengelola peralatan medis dari aspek K3 (inventaris, penandaan, uji fungsi, kalibrasi, dan pemeliharaan berkala).					
11	Puskesmas melakukan simulasi kondisi darurat/bencana dan simulasi kebakaran minimal 1 (satu) tahun sekali pada setiap gedung.					
12	SDM Puskesmas mampu menggunakan APAR dan kondisi/masa pakai APAR dipantau minimal 2 (dua) kali dalam setahun.					
13	Puskesmas mengelola bahan dan limbah B3 (inventarisasi, penyimpanan, lembar data keselamatan SDS/MSDS, spill kit, rambu/simbol, SOP) sesuai ketentuan.					
14	Penggunaan APD diterapkan sesuai standar.					
15	Terdapat prosedur tanggap darurat yang diterapkan.					

D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pemanfaatan Data K3

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Puskesmas melakukan evaluasi program K3 secara berkala (bulanan/triwulan).					
2	Hasil pencatatan K3 dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.					
3	Puskesmas mengalami kendala dalam menganalisis data K3 akibat sistem yang belum digital.					
4	Puskesmas melakukan inspeksi tempat kerja secara teratur oleh Tim/Penanggung Jawab K3 menggunakan daftar periksa (checklist).					
5	Puskesmas melakukan penilaian internal K3 oleh penanggung jawab paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.					
6	Puskesmas mengevaluasi capaian program K3 minimal 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan rencana kegiatan tahunan.					
7	Puskesmas melakukan peninjauan kinerja K3 setiap tahun terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, serta pemantauan dan evaluasi.					
8	Puskesmas menetapkan indikator kinerja K3 yang akan dicapai setiap tahun.					
9	Hasil peninjauan dan evaluasi ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja K3.					

10	Rekomendasi hasil audit/penilaian internal K3 ditindaklanjuti.					
11	Perubahan kebijakan K3 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.					

E. Kebutuhan Pengembangan Sistem Digital Pelaporan K3

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Puskesmas membutuhkan aplikasi digital untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan K3.					
1.	Puskesmas membutuhkan aplikasi yang dapat menghasilkan laporan K3 semester (kasus K3, PAK, kecelakaan kerja, near miss, hari absen) secara otomatis.					
2.	Puskesmas membutuhkan aplikasi yang dapat merekap laporan tahunan seluruh kegiatan K3 Puskesmas.					
3	Puskesmas membutuhkan fitur notifikasi/monitoring tindak lanjut insiden K3 secara real-time.					
4	Puskesmas membutuhkan sistem yang dapat merekam data risiko berdasarkan jenis bahaya (biologis, kimia, fisik, ergonomi, psikososial) secara terpisah.					
5	Puskesmas bersedia menjadi lokasi uji coba aplikasi pelaporan K3 berbasis mobile dan web apabila disediakan.					
6	Puskesmas membutuhkan sistem pelaporan berjenjang yang langsung terhubung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.					

Skala penilaian menggunakan skala Likert sebagai berikut:

1 = Tidak Ada
2 = Ada tetapi belum berjalan
3 = Berjalan sebagian
4 = Berjalan dengan baik
5 = Sangat baik dan terdokumentasi

< 40% = Tidak Memenuhi
40–59% = Perlu Perbaikan Mayor
60–79% = Memenuhi Sebagian
80–89% = Memenuhi Standar
≥ 90% = Unggul / Best Practice

Catatan : Mas Dean , Tulisan berwarna biru adalah point2 yang perlu ditambahkan/ diperbaiki, warna hitam point lama tetap ada, warna merah didelete. Mhn bantuannya untuk perbaiki, karena untuk menyimpulkan dengan kategori yang telah ditentukan masih banyak poin yang belum

dicantumkan . Nanti saya tambah biaya perbaikannya. Mudah2an sabtu bisa selesai dan kita ketemu sabtu sore. Tks byk,sehat dan sukses selalu.....

Lampiran

OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA K3 PUSKESMAS
Instrumen Permenkes dan Instrumen Akreditasi Puskesmas

Nama Puskesmas : ……

Alamat : ……

Tanggal Observasi : ……

A. PROTEKSI KEBAKARAN DAN KEDARURATAN

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	APAR tersedia, sesuai kapasitas/kebutuhan, mudah diakses, dan dalam kondisi baik	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Sprinkler tersedia sesuai kebutuhan bangunan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Heat detector/smoke detector tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Sistem alarm kebakaran/bencana tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Tangga darurat tersedia dan memenuhi persyaratan keselamatan (bila diperlukan)	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Pintu darurat tersedia, tahan api, dan memiliki tanda EXIT (bila diperlukan)	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Jalur evakuasi tersedia, jelas, dan tidak terhalang	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Rambu keselamatan dan tanda pintu/jalur darurat tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Titik kumpul (assembly point) tersedia dan ditandai	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Lift memenuhi standar keselamatan (bila tersedia)	☐	☐	Baik / Buruk	

B. BANGUNAN DAN UTILITAS UMUM

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Struktur bangunan/gedung dalam kondisi aman dan layak digunakan	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Atap, langit-langit, dinding, lantai, dan jendela dalam kondisi baik	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Instalasi listrik tersedia dan berfungsi dengan aman	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Sistem pencahayaan ruangan memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Sistem grounding/pembumian tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Ventilasi alami dan/atau buatan memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Sistem sanitasi, air bersih, dan pembuangan air kotor/limbah tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Tempat penampungan sementara sampah tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Toilet tersedia, higienis, dan jumlahnya memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Tempat parkir tersedia dan memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
11	Tangga bangunan aman digunakan (untuk gedung bertingkat)	☐	☐	Baik / Buruk	
12	Ruang ibadah tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
13	Ruang ganti tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
14	Ruang bayi dan ruang ASI tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
15	Air minum tersedia, serta air untuk kegunaan khusus (ruang tindakan dan laboratorium) sesuai ketentuan	☐	☐	Baik / Buruk	

C. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Penutup kepala tersedia sesuai kebutuhan risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Pelindung pendengaran (ear muff/ear plug) tersedia sesuai kebutuhan risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Kacamata pelindung/safety goggles tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Pelindung wajah/face shield tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Masker/respirator tersedia sesuai tingkat risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Sarung tangan tersedia sesuai jenis pekerjaan	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Pelindung kaki/sepatu keselamatan tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Jas laboratorium tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Apron tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Coverall tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	

D. SARANA DAN PRASARANA K3 LABORATORIUM

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Wastafel dilengkapi sabun/disinfektan kulit dan air mengalir	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Lemari asam (fume hood) dengan sistem exhaust tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Pipetting aid/rubber bulb tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Safety box/kontainer khusus benda tajam tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Emergency shower tersedia sesuai risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Kabinet keamanan biologis (biosafety	☐	☐	Baik / Buruk	

	cabinet) tersedia sesuai kebutuhan				
7	Eye wash/body wash tersedia sesuai risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Alas kaki/sepatu tertutup anti slip tersedia dan digunakan oleh SDM laboratorium	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Masker dan sarung tangan tersedia bagi SDM laboratorium	☐	☐	Baik / Buruk	

E. PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Daftar inventaris bahan dan limbah B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Tempat penyimpanan/pewadahan B3 sesuai karakteristik bahan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS/SDS) tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Spill kit untuk penanganan tumpahan/kebocoran B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Rambu dan simbol B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
6	APD tersedia sesuai karakteristik bahan dan limbah B3	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Sistem kedaruratan tumpahan/kebocoran bahan dan limbah B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
8	SOP pengelolaan bahan dan limbah B3 tersedia (pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan)	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Bahan B3 mudah terbakar dan gas medis disimpan di tempat yang aman	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Kesepakatan jaminan keamanan kerja tersedia bila pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh pihak ketiga	☐	☐	Baik / Buruk	

F. PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Tempat sampah terpilah organik dan nonorganik tersedia dan dilengkapi tutup	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Kantong plastik pelapis tempat sampah tersedia sesuai jenis sampah	☐	☐	Baik / Buruk	
3	APD petugas kebersihan (masker, sarung tangan, sepatu boots) tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Sarana cuci tangan dengan sabun tersedia bagi petugas setelah mengelola sampah	☐	☐	Baik / Buruk	

G. RANTAI DINGIN VAKSIN (COLD CHAIN)

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Vaccine refrigerator tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Cold box tersedia dan layak digunakan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Vaccine carrier tersedia dan layak digunakan	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

H. SARANA PENDUKUNG ERGONOMI

No.	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Kursi kerja memiliki sandaran dan tinggi yang dapat disesuaikan	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Footrest/pijakan kaki tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Document holder/penyangga dokumen tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Troli tersedia untuk mengangkut barang berat/tinggi	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Lift barang tersedia sesuai kebutuhan (bila tersedia)	☐	☐	Baik / Buruk	

6	Tata letak ruang kerja memberikan ruang udara minimal 10 m³ per pekerja	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Lantai ruang kerja bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Lemari peralatan dan material kerja tidak mengganggu lalu lintas SDM, dengan benda berat di bagian bawah	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Tangga tidak digunakan untuk menyimpan barang atau berkumpul	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Tempat duduk untuk istirahat sejenak tersedia bagi SDM yang bekerja dengan posisi berdiri lama	☐	☐	Baik / Buruk	
11	Bangku/pijakan khusus tersedia untuk menjangkau alat kerja yang tinggi atau untuk ruang persalinan (bila diperlukan)	☐	☐	Baik / Buruk	

I. BANGUNAN DAN AKSESIBILITAS

No.	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Kondisi bangunan dan ruangan Puskesmas layak dan aman digunakan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Pencahayaan ruangan memadai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Ventilasi/penghawaan ruangan memadai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Kamar mandi/WC tersedia dan dalam kondisi layak	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Akses masuk/jalur kursi roda (ramp) tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Handrail/pegangan tangan tersedia pada area yang membutuhkan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Tempat parkir tersedia dan memadai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

J. SISTEM UTILITAS DAN PRASARANA PENDUKUNG

No.	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Sistem kelistrikan tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Sumber listrik cadangan (genset/UPS) tersedia dan dapat digunakan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Sistem air bersih tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Sistem sanitasi dan hygiene tersedia dan terpelihara	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Sistem komunikasi (telepon/internet) tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Sistem gas medik/oksigen tersedia sesuai kebutuhan pelayanan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Cadangan gas medik tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Sistem proteksi petir tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
9	Sistem pengelolaan limbah cair/IPAL tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

K. KESELAMATAN, KEBAKARAN, DAN EVAKUASI

No.	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	APAR tersedia, mudah diakses, dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Sistem deteksi dini dan/atau alarm kebakaran tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Jalur evakuasi tersedia, jelas, dan tidak terhalang	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Tanda/rambu jalur dan pintu darurat tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

5	Titik kumpul (assembly point) tersedia dan ditandai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Rambu larangan merokok tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Rambu keselamatan/K3 tersedia pada area yang diperlukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Kotak P3K tersedia dan mudah diakses	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

L. PENGELOLAAN LIMBAH DAN B3

No.	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Tempat sampah medis/infeksius dan nonmedis tersedia secara terpisah	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	TPS limbah B3 tersedia dan sesuai ketentuan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Spill kit untuk penanganan tumpahan B3 tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Pengelolaan dan pemilahan limbah B3 dilaksanakan sesuai prosedur	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

M. PERALATAN KESEHATAN DAN PEMELIHARAAN

No.	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Peralatan kesehatan utama tersedia sesuai kebutuhan pelayanan/ASPAK	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Inventarisasi peralatan kesehatan dilakukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Inspeksi dan pengujian peralatan kesehatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Pemeliharaan peralatan kesehatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Kalibrasi peralatan kesehatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

6	Penandaan peralatan medis yang digunakan dan yang tidak digunakan tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Uji fungsi dan uji coba peralatan medis dilakukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Penyimpanan dan penggunaan peralatan medis sesuai SOP	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
9	Daftar periksa (checklist) pemantauan pengelolaan peralatan medis tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

N. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

No.	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Terdapat petugas/PJ yang bertanggung jawab terhadap MFK	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Program MFK ditetapkan berdasarkan identifikasi risiko	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Identifikasi area berisiko dilakukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Inspeksi fasilitas bangunan, prasarana, dan peralatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Simulasi tanggap darurat/kode darurat dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Simulasi dan evaluasi kesiapsiagaan bencana/kebakaran dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Program MFK dievaluasi dan ditindaklanjuti	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

< 40% = Tidak Memenuhi
40–59% = Perlu Perbaikan Mayor
60–79% = Memenuhi Sebagian

80–89% = Memenuhi Standar
≥ 90% = Unggul / Best Practice

Point-poin yang perlu ditambahkan dalam program:

1. Tambahkan bukti fisik data Dukung untuk tiap jawaban
2. Bisa dilihat perpoint dari masing2 puskesmas yang tidak dilaksanakan (kuesioner) dan tidak ada (observasi)
3. Kategori pelaksanaannya

   Perhitungan kategori :

< 40% = Tidak Memenuhi
40–59% = Perlu Perbaikan Mayor
60–79% = Memenuhi Sebagian
80–89% = Memenuhi Standar
≥ 90% = Unggul / Best Practice

4. Rekapitulasi di Dinas Kesehatan dari data Puskesmas
5. Tampilkan lambang Dinkes Kota Pontianak
6. Pass Word untuk admin Puskesmas